

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Έστω, ότι ο ιατρός αποφασίζει να συνταγογραφήσει ένα φάρμακο, χειρόγραφα, σε ένα τυποποιημένο λευκό χαρτί συνταγής («*φίρμα*»), π.χ. το αντιβιοτικό Κεφακλόρη (*Ceclor*): Θα γράψει λοιπόν, επί παραδείγματι, τη συνταγή, ως εξής:

Rp. caps. Ceclor MR 750 mg, bt No II (δύο).

S: 1 x 2, για 10 ημέρες.

Η σύντμηση “caps” υποδηλώνει κάψουλες. Η σύντμηση “bt” σημαίνει *boite* = κουτιά, ενώ “bt No II (δυο)” σημαίνει ότι ο ασθενής θα πάρει δυο κουτιά από το συγκεκριμένο φάρμακο. Ο συμβολισμός “1x2” σημαίνει δοσολογία: 1 κάψουλα δύο φορές ημερησίως (ανά 12 ώρες).

Αν ο ιατρός επιθυμούσε να δώσει το Ceclor σε μορφή σιροπιού, τότε θα έγραφε:

Rp. Syrup Ceclor 375 mg, bt No I (ένα).

S: 7 ml x 2 (ανά 12ωρο), για 7 ημέρες.

Όπως φαίνεται στο Εθνικό Συνταγολόγιο του ΕΟΦ ή σε ειδικούς καταλόγους και σελίδες φαρμάκων (καλό είναι να τα έχουμε προμηθευτεί ή να ανατρέξουμε στο διαδίκτυο - π.χ. στην ιστοσελίδα «Γαληνός»), το αντιβιοτικό Ceclor κυκλοφορεί στις εξής μορφές:

- | | |
|------------------------|------------------|
| ▪ Caps. 500 mg, | ▪ syrup. 250 mg, |
| ▪ tabl. retard 750 mg, | ▪ syrup. 375 mg. |
| ▪ syrup. 125 mg, | |

Η γραφή “tabl retard” υποδηλώνει «ταμπλέτες βραδείας αποδέσμευσης».

Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα με το αντιφλεγμονώδες Δικλοφαινάκη (*Voltaren*).

Αυτό το φάρμακο κυκλοφορεί στις ακόλουθες μορφές:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ▪ tabl. 25 mg, | ▪ tabl. retard 100 mg, |
| ▪ tabl. 50 mg, | ▪ amp. 75 mg, |
| ▪ tabl. disp. 50 mg, | ▪ supp. 50 mg, |
| ▪ tabl. retard 75 mg, | ▪ gel 1% |

Amp. = αμπούλες, *supp.* = υπόθετα, *gel* = γέλη.

Έτσι, λοιπόν, ένα άλλο σχετικό παράδειγμα συνταγογράφησης της Δικλοφαινάκης, είναι:

Rp. supp. Voltaren 50 mg, bt No I (ένα).

**S: 1x2, για τις πρώτες 2-3 ημέρες
και 1x1 για τις επόμενες 3 ημέρες.**

▪ Πώς συνταγογραφούνται τα φάρμακα των χρονίων παθήσεων;

Επί χρονίων παθήσεων ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου, όπως και κάθε ιατρός, πρέπει να συνταγογραφεί τόσα κουτιά ώστε ο ασθενής να έχει φάρμακα για έναν μήνα, περίπου.

Αν π.χ. το κουτί έχει 30 ταμπλέτες και ο ασθενής παίρνει μια ταμπλέτα το πρωί και μια ταμπλέτα το βράδυ, θέλει συνολικά 60 το μήνα, δηλαδή 2 κουτιά. Αν το κουτί έχει 10 tabl. και ο ασθενής παίρνει 1 tabl. την ημέρα, είναι προφανές ότι χρειάζεται 3 κουτιά το μήνα.

Για ευκολία, σημειώνουμε πάνω σε κάθε γνωμάτευση, δίπλα σε κάθε όνομα φαρμάκου τον αριθμό των δισκίων που περιέχει το κουτί. (Πραγματικά, είναι πολύ βοηθητικό! Αν και κουραστικό, παρ’ όλα αυτά σε έναν περίπου μήνα που θα κλείσει ο κύκλος, σε όλες τις γνωματεύσεις θα υπάρχει συμπληρωμένος ο αριθμός των δισκίων κάθε φαρμάκου).

▪ **Ποια νοσήματα χαρακτηρίζονται ως «οξεία»;**

Θεωρητικά οποιαδήποτε, αρκεί ο ιατρός να τα ονοματίσει σωστά στη διάγνωση, βάσει ICD-10 (π.χ. *λοίμωξη αναπνευστικού, οξεία προστατίτιδα, βήχας, κνιδωτικό εξάνθημα, κ.ά.*).

Βέβαια, διαφέρει η Αρτηριακή Υπέρταση από το οξύ υπερτασικό επεισόδιο. Όπως και άλλο εννοούμε αναγράφοντας ΧΑΠ και άλλο οξεία βρογχίτις ή παρόξυνση ΧΑΠ. Εντελώς διαφορετικό είναι επίσης το γαστρικό έλκος από τη γαστρίτιδα, τη ΓΟΠΝ ή τη δυσπεψία.

▪ **Κάθε πότε συνταγογραφούνται στον ασθενή τα ίδια φάρμακα;**

Κάθε περίπου 28-30 ημέρες. Ο νόμος δίνει περιθώριο 5 μέρες. Δηλαδή μπορεί να έρθει μόλις συμπληρωθούν 25 ημέρες από την τελευταία φορά που γράφτηκε το ίδιο φάρμακο.

▪ **Πως συνταγογραφεί – γενικώς – φάρμακα ο ιατρός άνευ ειδικότητας;**

Βάσει επικαιροποιημένου νόμου, που ισχύει από τις 28/03/2012, ο ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου (υπόχρεος ή επί θητεία) μπορεί να συνταγογραφεί φάρμακα μόνον για τα οξεία - επείγοντα περιστατικά, και μόνο ένα κουτί (*εμβολάγιο*) από κάθε φάρμακο που επιλέγει.

Για χρόνια νοσήματα, όπως π.χ. ΑΥ, στεφανιαία νόσος (ΣΝ), ΣΔ, υποθυρεοειδισμός, ΓΟΠΝ, δυσλιπιδαιμίες, ΧΑΠ, άσθμα, κατάθλιψη - χρόνιες αγχώδεις διαταραχές, θεραπεία νεοπλασιών, κ.λπ. χρειάζεται οπωσδήποτε μια πρόσφατη γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού σχετικής οπωσδήποτε ειδικότητας με το φαρμακευτικό σκεύασμα που συνταγογραφείται.

▪ **Μπορεί ο ειδικευόμενος ιατρός να εκδώσει ιατρική γνωμάτευση;**

Όχι! Για τους ειδικευόμενους προς το παρόν ισχύει ό,τι και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου. Συνταγογραφούν δηλαδή φάρμακα βάσει γνωμάτευσης ειδικού ιατρού και εάν συντάξουν εκ παραδρομής γνωμάτευση (π.χ. *για χρόνια αγωγή ΑΥ*), αυτή δεν θα ισχύει.

▪ **Κι αν ο ασθενής δεν έχει εξασφαλίσει γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού;**

Σε αυτή την περίπτωση, τα πράγματα περιπλέκονται λίγο. Σε χρόνια νοσήματα όπως ΑΥ, ΣΝ, Δυσλιπιδαιμία, ΣΔ, Οστεοπόρωση, κακοήθεια, διπολική διαταραχή, Ψυχώσεις, κ.ά., δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ή «παραθυράκια» για τη διευκόλυνση του ασθενούς.

Στην περίπτωση αυτή παραπέμπουμε τον ασθενή σε ειδικευμένο ιατρό ή προσπαθούμε να πεισθεί ο ασθενής να βρει έναν ειδικό ιατρό – όσο και αν είναι δύσκολο γι' αυτόν – για να του χορηγήσει μία υπογεγραμμένη γνωμάτευση-συνταγή. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε σαν γνωμάτευση τη συνταγή (*από το ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ*) του ειδικού ιατρού που γράφτηκε πρόσφατα και επιβεβαιώνει τη σχετική φαρμακευτική αγωγή.

Σε άλλες παθήσεις, όπως π.χ. του γαστρεντερικού, πνευμονοπάθειες, δερματοπάθειες, κοινές οφθαλμοπάθειες (όχι γλαύκωμα), οστεοαρθροπάθειες κ.λπ. τα πράγματα είναι πιο εύκολα, με την έννοια ότι ο «αγροτικός» ιατρός μπορεί να δικαιολογήσει – προσωρινά – τα φάρμακα που γράφει με την κατάλληλη διάγνωση, π.χ. γαστρίτις, δερματίτις, επιπεφυκίτις, βρογχίτις-λοίμωξη αναπνευστικού, αρθρίτις, οσφυαλγία, κρίση πανικού, κ.λπ.

Σε καμία περίπτωση δεν αρνούμαστε στον ασθενή τη συνταγή των φαρμάκων του, αλλά προσπαθούμε - στο μέτρο του δυνατού - να βρούμε άμεσα λύση στο πρόβλημα!

▪ **Πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η γνωμάτευση του ειδικού ιατρού;**

Ο ειδικευμένος ιατρός γράφει σε μια συνταγή και γνωματεύει φάρμακα αποκλειστικά της ειδικότητάς του και πρέπει να αναγράφει για πόσο ισχύει η γνωμάτευση που εκδίδει. Το μέγιστο όριο είναι 2 χρόνια. Αν δεν αναγράφεται κάτι, τότε θεωρείται ότι η γνωμάτευση ισχύει για 2 χρόνια. Παρότι ο νόμος επιτρέπει τη διετή ισχύ της συνταγής, το Υπουργείο Υγείας συνιστά στους ιατρούς να συντάσσουν ή να ζητούν νέα γνωμάτευση σε 6-12 μήνες.

▪ **Τι ισχύει με τα φάρμακα που υπάγονται στο νόμο περί ναρκωτικών ουσιών;**

Πρόκειται για σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες που υπάγονται στο νόμο περί ναρκωτικών. Τέτοια φάρμακα είναι τα αγχολυτικά, τα υπναγωγά, τα παυσίπονα, όπως:

Stedon, Xanax, Tavor, Lexotanil, Tranxene, Hipnosedon, Vulbegal, Gardenal, Diphenal, Stilnox, Halcion, Imovane, Librax, Loramet, Sival-b, Lonarid-N, Lonalgal, Tramal, Zaldiar, Skudexa, κ.λπ.

Με το άρθρο 90 του νόμου 4600/2019 (Α' 43), τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκων, στο σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. Λόγω κατάργησης της χειρόγραφης κόκκινης μονόγραμμης συνταγής, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν να γράφονται ναρκωτικά φάρμακα στις κάτωθι κατηγορίες ασθενών:

- Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.
- Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι δεν κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).
- Μετανάστες, που για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ.
- Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται - *εκτάκτως και με ατομικά δελτία παραγγελίας, μέσω του ΙΦΕΤ* - ναρκωτικά φάρμακα του εξωτερικού.
- Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Κατόπιν τούτου, και μόνον για τις προειρημένες κατηγορίες ασθενών, θα συνεχιστεί - μέχρι νεωτέρας - το χειρόγραφο σύστημα συνταγογράφησης των ναρκωτικών φαρμάκων (*μονόγραμμες ή δίγραμμες συνταγές*), με παράλληλη θεώρηση των βιβλιαρίων ειδικών συνταγών ναρκωτικών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών.

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ασθενών θα εξακολουθήσει, αυστηρά, να ισχύει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των ναρκωτικών φαρμάκων, όπως αυτή πλέον ορίζεται στο άρθρο 90 του νόμου 4600/2019 και εφαρμόζεται βάσει τούτου από 15-07-2019.

▪ **Τι ισχύει με τα φάρμακα εκείνα όπου κάθε κουτί περιέχει μόνο μία δόση;**

Υπάρχουν αρκετά ενέσιμα αντιβιοτικά, ενέσιμα ΜΣΑΦ, κορτικοστεροειδή κ.ά., που το κουτί περιέχει μια μόνο δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου για οξύ περιστατικό, χωρίς δηλαδή γνωμάτευση ειδικού, ο αγροτικός ή ο ειδικευόμενος ιατρός έχει δικαίωμα να γράψει θεραπεία για 36 ώρες. Αν δηλαδή η δοσολογία είναι μια ένεση κάθε 12 ώρες, ο ιατρός δικαιούται να γράψει 3 κουτιά της μιας δόσης. Όταν περάσουν οι 36 ώρες μπορεί να ξαναγράψει το φάρμακο για άλλες 36 ώρες κ.ο.κ., μέχρι την συμπλήρωση της θεραπευτικής αγωγής. Εφόσον βέβαια υπάρχει ιατρική γνωμάτευση από ειδικό ιατρό, τότε βάσει αυτής μπορούν να συνταγογραφηθούν όσα κουτιά χρειάζονται για τη θεραπεία του ασθενούς.

▪ **Τι ορίζεται στην περίπτωση εκείνη που ο ασθενής προσέλθει για συνταγή προτού συμπληρωθούν 30 ημέρες από την τελευταία φορά που έγραψε κάποιο φάρμακο;**

Κανονικά ο ασθενής πρέπει να επανέλθει σε 30 ημέρες για να γράψει το ίδιο φάρμακο. Ο νόμος δίνει περιθώριο ± 5 ημέρες. Δηλαδή μπορεί να έρθει ακόμα και στις 25 ημέρες.

Καλό είναι να προσπαθήσουμε εξ αρχής να μάθουν οι ασφαλισμένοι πότε θα πρέπει να έρχονται. Χωρίς να είμαστε όμως απόλυτοι. Αν μια υπέργερη κυρία περιμένει επί ώρα στη σειρά ή ανέβηκε ασθμαίνουσα ολόκληρη ανηφόρα ως το ιατρείο, ας μην αρνηθούμε να της γράψουμε, έστω και λίγο νωρίτερα, τα φάρμακα. Πρέπει όμως να της εξηγήσουμε ότι ήρθε νωρίς, ώστε να εκτιμήσει την καλή μας πρόθεση και πράξη, αλλά και για να μην θεωρήσει ότι μπορεί κάθε φορά να έρχεται όποτε το θυμηθεί, αφού ο ιατρός είναι ελαστικός.

Προσπαθούμε λοιπόν να εξηγήσουμε στους ασφαλισμένους τους όρους λειτουργίας του ιατρείου και της συνταγογράφησης, ώστε να διατηρήσουμε τον έλεγχο από την αρχή, ενώ σωστό είναι να είμαστε σταθεροί στην εφαρμογή αυτού του κανόνα, πάντοτε, προς όλους.

▪ **Τι γίνεται με τους ασθενείς που «χρωστάνε» πολλά φάρμακα στο φαρμακείο;**

Πρόκειται για ένα κοινό, διαχρονικό πρόβλημα, σε κάθε περιοχή αγροτική ή αστική. Αν πρόκειται για φαρμακευτικό σκεύασμα οξείας νόσου π.χ. πανσίπνο, το πρόβλημα είναι μικρό, αν και μερικές φορές η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο φαρμακοποιός δίνει άτυπα - «προς εξυπηρέτηση» - στον ασθενή π.χ. μια Κινολόνη για μία απλή κυστίτιδα, την οποία οι αγροτικοί ιατροί ή οι ειδικοί «υποχρεούνται» να την γράψουν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.

Εκεί, όπου όντως η κατάσταση περιπλέκεται, είναι στα χρόνια νοσήματα, που υπάρχει περιορισμός για τον ιατρό, στο κάθε πόσο συχνά και πόσα εμβολάγια θα συνταγογραφήσει, ενώ παράλληλα ο χρήστης υπηρεσιών υγείας συνεχίζει να παίρνει φάρμακα για το νόσημα.

Ορισμένες λύσεις, για να «ξεχρεώσει» ο ασθενής το φαρμακείο, είναι οι εξής:

1. Να γράφονται οι συνταγές στις 25 ημέρες και όχι στις 30 (*κερδίζει 5 ημέρες τον μήνα*). Δηλαδή, να συνταγογραφεί ο ιατρός λίγο νωρίτερα τα φάρμακα (*αξίζει τον κόπο η «παρατυπία», ιδίως αν έτσι δοθεί λύση και ο ασθενής ξεχρεώσει τα οφειλόμενα φάρμακα*).
2. Κάποια κουτιά έχουν π.χ. 20 δισκία. Για τη θεραπεία ενός μήνα ο ασθενής χρειάζεται κανονικά δυο κουτιά. Αν ξαναέρθει σε 25-30 ημέρες και συνταγογραφηθούν άλλα δύο κουτιά θα έχει κερδίσει περίπου ενάμισι κουτί κι έτσι το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα.

Είναι βέβαιο, ότι θα βρείτε κι άλλους νομότυπους τρόπους, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση.

▪ **Ποιες οι συνέπειες, αν ο ιατρός αναγράψει λάθος διάγνωση ή λάθος ποσοστό;**

Ίσως εδώ μπορεί ο ιατρός να πέσει σε παγίδα. Υπάρχουν περιπτώσεις που επιβλήθηκαν δυσθεώρητα πρόστιμα ακόμη και μετά από 2-5 χρόνια (*τόσο χρόνο κάνουν να ελεγχθούν οι συνταγές*) σε ιατρούς που έβαζαν συστηματικά ποσοστό 10% ή 0% για κοινά νοσήματα (αντί του ορθού 25%) ή ανέγραφαν εσφαλμένες διαγνώσεις για φαρμακευτικά σκεύασματα.

Με το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το πρόβλημα αυτό έχει εν μέρει επιλυθεί με την αυτόματη αναγραφή του ποσοστού του φαρμάκου αναλόγως της παθήσεως.

Προσοχή! Δεν έχει σημασία το ποσοστό που έχει βάλει ο ειδικός ιατρός στη γνωμάτευση. Αν π.χ. ο ασθενής φέρει γνωμάτευση, με διάγνωση αρτηριακή υπέρταση, για ένα φάρμακο όπως: *tab. Telmisartan 40 mg*, κι αναγράψει συμμετοχή 10%, τότε είναι λάθος. Εφόσον στη συνταγή διαπράξουμε το ίδιο λάθος, τότε η ΗΔΙΚΑ θα εγκалέσει εμάς και όχι τον ειδικό. Την ευθύνη της εκάστοτε συνταγής (και παραπεμπτικού) φέρει αποκλειστικά και μόνον ο υπογράφων ιατρός (και ίσως, δευτερευόντως, και ο φαρμακοποιός που εκτελεί τη συνταγή).

▪ **Και αν η γνωμάτευση του ειδικού ιατρού είναι παράλογη ή εσφαλμένη;**

Παραδείγματα:

1. Αν η γνωμάτευση του ειδικού έχει λάθος ποσοστό συμμετοχής, εμείς βάζουμε το σωστό βάσει της πάθησης ή των φαρμάκων, είτε προς όφελος, είτε προς ζημιά του ασθενούς.
2. Αν αναγράφει λιγότερα ή περισσότερα σε αριθμό κουτιά (*εμβολάγια*) σε σχέση με αυτά που απαιτούνται, τότε διορθώνουμε ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες για ένα μήνα. Αν δεν αναγράφεται η δοσολογία αποφασίζουμε εμείς για αυτή, βάσει των αποδεκτών κανόνων και αλγόριθμων ή μετά από συζήτηση με τον ασθενή. Αν δεν είμαστε σίγουροι μπορούμε στη θέση της οδηγίας να αναγράψουμε π.χ. *«χορήγηση βάσει οδηγιών του τάδε ειδικού ιατρού»* και να επιλέξουμε ένα λογικό αριθμό κουτιών π.χ. για θεραπεία μηνός.
3. Αν η διάγνωση που αναγράφεται στη γνωμάτευση δε συνάδει με τα φάρμακα, εμείς θα γράψουμε τη σωστή διάγνωση ή οπωσδήποτε μια συμβατή με τα φάρμακα διάγνωση.
4. Αν λείπει η ημερομηνία της γνωμάτευσης του ειδικού, συμπληρώνουμε μια ημερομηνία ρωτώντας τον ασθενή πότε επισκέφθηκε τον ειδικό ιατρό (*είναι απαραίτητο να φαίνεται και η ημερομηνία και η ειδικότητα του Ιατρού που έχει εκδώσει την ιατρική γνωμάτευση*).

▪ Επαναλαμβανόμενη συνταγή.

Η επαναλαμβανόμενη συνταγή έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει όσους δυσκολεύονται να έρχονται κάθε μήνα στο γιατρό για να γράφουν τα φάρμακά τους. Ο ιατρός συνταγογραφεί επαναλαμβανόμενη συνταγή έως 3 μήνες (αν είναι υπόχρεος ΥΥ ή επί θητεία) και έως 6 μήνες (αν είναι ειδικός). Κάθε μήνα, ο ασθενής το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάει στο φαρμακείο και να εκτελέσει τη συνταγή στις αναγραφόμενες ημερομηνίες εκτέλεσης.

Παράδειγμα:

Έστω, ένας ασθενής λαμβάνει ως μακροχρόνια αγωγή για τον σακχαρώδη διαβήτη, τα εξής φάρμακα:

tab. Glucophage 850 mg, 1x2 και *tab. Diamicron MR 30 mg, 1x2*

και θέλουμε να εκδώσουμε 3μηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή.

1. Αρχικά, θα επιλέξουμε την επιλογή «3μηνη» στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οπότε μετά το πέρας της διαδικασίας θα εκτυπωθούν αυτομάτως 3 έντυπα συνταγών (με διαφορετικά Barcodes), που το καθένα εξ αυτών αναγράφει επάνω δεξιά τις ημερομηνίες εκτέλεσης της συνταγής ή επί χειρόγραφης συνταγής θα χρησιμοποιήσουμε τρεις (3) συνεχόμενες σελίδες του συνταγολογίου.
2. Προφανώς, για να «περάσει το μήνα» ο ασθενής μας, θα χρειαστεί 2 κουτιά Glucophage (x 30 δισκία) και 2 κουτιά Diamicron (x 28 δισκία). Σε καθένα από τα τρία φύλλα θα αναγραφούν αυτές τις ποσότητες.
3. Θα αναγράψουμε όπως πάντα «ιατρική γνωμάτευση του τάδε παθολόγου - διαβητολόγου, κ.λπ.».
4. Επί χειρόγραφης συνταγής, ως ημερομηνία θα αναγράψουμε την ίδια και στα τρία φύλλα των συνταγών (δηλαδή την ημερομηνία εκείνη που γράψαμε τις συνταγές).
5. Επιπλέον, σε κάθε φύλλο της συνταγής θα αναγράψουμε τα εξής:
"Επαναλαμβανόμενη συνταγή - αρ. φύλλου Νο 1 ή Νο 2 ή Νο 3" (στο 1^ο, 2^ο και 3^ο φύλλο αντίστοιχα).
Στο κάτω μέρος θα βάλουμε τη μονογραφή, τη σφραγίδα μας και τη σφραγίδα της υγειονομικής δομής.
Έτσι, αν π.χ. γράψαμε μια 3μηνη συνταγή στις 23 Μαρτίου, ο ασθενής θα εκτελέσει την 1^η συνταγή στις 23 Μαρτίου, την 2^η συνταγή στις 23 Απριλίου και την 3^η στις 23 Μαΐου (± 5 ημέρες για κάθε μήνα).

Είναι σημαντικό να τηρηθούν αυτές οι ημερομηνίες από τον ασθενή μας. Αν ο ασθενής παραλείψει να εκτελέσει μια συνταγή στην προβλεπόμενη ημερομηνία εκτέλεσής της, τότε μπορούμε να αναγράψουμε νέα απλή συνταγή προς αντικατάσταση της μη εκτελεσθείσας ή να ακυρώσουμε την 3μηνη συνταγή και να γράψουμε μια καινούργια.

Όταν παρέλθουν οι τρεις μήνες της επαναλαμβανόμενης 3μηνης συνταγής, μόνον τότε, μπορεί ο ασθενής να ξαναγράψει τα ίδια φάρμακα. Φυσικά, μπορεί να γράφει οποιοδήποτε άλλο φάρμακο στο χρονικό αυτό διάστημα για άλλο νόσημα. Το ίδιο – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – μπορεί να γίνει για περισσότερους μήνες (έως έξι).

Συνήθως, στην έναρξη μιας μακροχρόνιας φαρμακευτικής αγωγής (π.χ. για ΑΥ ή ΣΔ) αποφεύγουμε να γράφουμε τρίμηνες συνταγές στους ασθενείς και προτιμούμε τις μηνιαίες, για να μπορούμε να ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στα αρχικά στάδια, τις πιθανές παρενέργειες και τη συμμόρφωση του ασθενούς στο νέο θεραπευτικό σχήμα.

▪ Το μέγα ζήτημα τού... «πόσα κουτιά θα μου γράψεις γιατρέ;»

Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον ασθενή ότι δε μπορούμε να συνταγογραφήσουμε αυθαίρετα. Ας μην ξεχνάμε ότι κάτι που εμείς θεωρούμε ότι είναι δεδομένο για όλους, κάποιοι άλλοι δεν το έχουν καν συνειδητοποιήσει και τους φαίνεται η άρνησή μας, ενώ αν εξηγήσουμε υπομονετικά και ευγενικά τους κανόνες, σίγουρα θα το κατανοήσουν.

Όταν φυσικά έχουμε το περιθώριο να γράψουμε παραπάνω, καλό είναι να καταλαβαίνει ο ασθενής ότι κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που δικαιούταν, ώστε να το εκτιμήσει.

▪ Στον ΟΓΑ χρειάζεται να γράφονται τα φάρμακα και στο μικρό βιβλιário;

Με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ο ιατρός δεν χρειάζεται πλέον να «ξεφυλλίσει» το βιβλιário του ασθενούς, αλλά μπορεί να ανατρέξει στο ιστορικό του - ηλεκτρονικά - και να αντλήσει όποιες πληροφορίες θέλει, σε βάθος χρόνου, οπότε με το σκεπτικό αυτό, αρκετοί ιατροί δεν γράφουν τα φάρμακα στο μικρό βιβλιário του ΟΓΑ. Παρ' όλα αυτά το βιβλιário ασθενείας μπορεί να βοηθήσει αρκετά (ιδίως σε καταστάσεις

πίεσης, όπως στο ΤΕΠ), δίνοντάς μας πληροφορίες άμεσα για τη φαρμακευτική αγωγή, για παλαιότερες εξετάσεις, τα αποτελέσματά τους, νοσηλείες ή άλλες θεραπείες του ασθενούς.

▪ **Θεωρημένα βιβλιάρια & ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς.**

Κανονικά ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την ισχύ του βιβλιαρίου (*φαίνεται στο μικρό βιβλιάριο ή ως αυτόματη ένδειξη στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης*).

Στην περίπτωση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το σύστημα της ΗΔΙΚΑ αμέσως μετά την πληκτρολόγηση των προσωπικών στοιχείων (ΑΜΚΑ) του ασθενούς, επιτρέπει την συνταγογράφηση φαρμάκων με μηδενική συμμετοχή στον ασθενή (νόμος 4368/2016) που δεν έχει ασφαλιστική ενημερότητα στο ταμείο του, με την αναγραφόμενη σύσταση προς τον ιατρό να αποφεύγει τη συνταγογραφία ακριβών σκευασμάτων. Με βάση τον ίδιο νόμο, επιτρέπει στον ασφαλισμένο τη διενέργεια εργαστηριακών ή απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων μόνο σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, επίσης με μηδενική συμμετοχή.

▪ **Συνταγογραφία εμβολίων.**

Τα εμβόλια τα οποία περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) μπορούν να συνταγογραφούνται με ποσοστό συμμετοχής 0% από ειδικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου ή θητείας. Η συνταγογράφηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις δοσολογικές οδηγίες του ΕΠΕ και τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, ως μέρος της τακτικής προληπτικής φροντίδας.

▪ **Έλεγχος των ιατρικών συνταγών.**

Ο έλεγχος των ιατρικών συνταγών γίνεται, χονδρικά, σε τρία επίπεδα.

1. Το πρώτο, αφορά στα φάρμακα τα οποία χρειάζονται θεώρηση από τον ελεγκτή του ασφαλιστικού ταμείου ή του ΕΟΠΥΥ (*κυρίως αφορά στα σκευάσματα υψηλού κόστους*).
2. Το δεύτερο επίπεδο, αφορά στον έλεγχο που πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ύστερα από μήνες και ασχολείται με την αρτιότητα των ιατρικών συνταγών. Ανιχνεύονται μπουζούρες ή διορθώσεις και ελέγχονται συνταγές που δε συνοδεύονται από υπογραφή και σφραγίδες (*ιατρού ή νοσηλευτικής δομής*) ή ασυμβατότητες των σφραγίδων.
3. Το τρίτο επίπεδο ελέγχου γίνεται πάλι δειγματοληπτικά, μετά από μήνες ή/και χρόνια. Στο στάδιο αυτό ανιχνεύονται λάθη στα ποσοστά φαρμακευτικής δαπάνης, λανθασμένη ή ασύμβατη διάγνωση, υπερσυνταγογραφία σκευασμάτων ή αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

Δε γνωρίζουμε αν και κατά πόσο κινδυνεύει κάποιος ιατρός ο οποίος κάνει σε γενικές γραμμές σωστά τη δουλειά του, ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιον μήνα ξεπεράσει το υπολογισθέν λογιστικό όριο (πλαφόν) συνταγογράφησης ανά ασθενή που αναγράφεται ως μήνυμα στην ηλεκτρονική καρτέλα στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ (*ή έρχεται σαν προσωπικό μήνυμα στην σελίδα του ΕΟΠΥΥ*), αλλά θεωρείται ότι η υπέρβαση του ορίου για έναν μόνο μήνα ή περιστασιακά δεν επισύρει σοβαρές νομικές συνέπειες.

▪ **Συνταγογράφηση άυλων συνταγών και παραπεμπτικών εξετάσεων.**

Η καθιέρωση της *Άυλης Συνταγογράφησης*, υπήρξε αναγκαία κατά την πανδημία του Covid-19, για τη διευκόλυνση και προστασία ασθενών και ιατρών. Σήμερα, παραμένει για ειδικές ομάδες ασθενών, με προβλήματα πρόσβασης στην ΠΦΥ (*χρονίως κατακεκλιμένοι, ανάπηροι, ασθενείς σε δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές χωρίς ιατρική κάλυψη, κ.ά.*) και υπό ειδικές περιπτώσεις. Ενημερώνουμε ευγενικά τους ασθενείς να μην κάνουν κατάχρηση του μέτρου αυτού - *μόνο και μόνο για λόγους δικής τους διευκόλυνσης* - αφού είναι αυτονόητο και προφανές ότι η άυλη συνταγογράφηση με την απρόσωπη τηλεφωνική «παραγγελία» φαρμάκων ή διαγνωστικών εξετάσεων, επ' ουδενί μπορεί να υποκαταστήσει την κλινική εξέταση, τη λήψη ιστορικού και πρωτίστως την ιερή σχέση κι επαφή ασθενούς - ιατρού.